

歯科保険診療 返戻・査定 頻出原因トップ20 — 算定チェックエンジン実装バックログ

docs/specs/henrei-satei-top20.md として保存可能な単一Markdownファイル。実装者がGitHub Issue/バックログチケットに分解できる粒度で記述。

0. 調査方法・「頻出」の判断基準・主要出典

調査方法と「頻出」の定義

本リストは以下の3層の根拠を統合して作成した。

1. 公式・準公式の定量／半定量データ（最優先）：社会保険診療報酬支払基金（以下、支払基金）が公開する「審査の差異の可視化レポート」（①審査情報提供事例レポート、②多くの付箋がつくコンピュータチェック事例レポート）。コンピュータチェックで多数の付箋（疑義フラグ）が付く事例＝実際に機械チェックで頻繁に引っかかる項目であり、本タスクの目的（機械チェックエンジン）に直結する一次情報。
2. 支払基金「審査情報提供事例（歯科）」「受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（歯科）」：前者は審査の一般的取扱い（病名と処置の整合の正解集）、後者は受付時の形式チェック仕様の一次資料。
3. 複数の保険医協会・歯科医師会・レセコンベンダー・実務解説で繰り返し言及される項目：兵庫県保険医協会、愛知県保険医協会、東京保険医協会、モリタ、WHITE CROSS (dStyle)、算定奉行かわら版、社会保険研究所「事例で学ぶ歯科レセプト作成と点検」等。

「頻出」と判断した基準：(a) 支払基金のコンピュータチェック付箋事例・審査情報提供事例に登載されている、(b) かつ複数（2つ以上）の独立した実務資料で「よくある返戻・査定」として言及されている項目を「頻出」とした。歯科の項目別件数の全国ランキングは網羅公開されていないため、純粋な発生件数順位ではなく「機械チェック適合性×実務頻度」で順位付けした。この点は限界として明記する。

確認できた数少ない定量データ

- 支払基金審査情報提供事例レポート 事例1「『G』（歯肉炎）のみに対する歯科疾患管理料の取扱い」（2020年9月28日付）。取扱い全文：「原則として、診療開始日から4か月以上経過した患者に対して、『G』病名のみで、歯科疾患管理料のみの算定を認める」。該当件数は全国4,986件（2020年9月～2021年8月審査分、取扱いに基づく審査＝請求どおり4,986件／検証を要する査定・返戻計0件）。＝「Gのみ歯管」は付箋が付きやすいが、原則は認められる類型。
- 支払基金「多くの付箋がつくコンピュータチェック事例（歯科）」で**「要フォローアップ」（＝都道府県間で査定/非査定の差異が大きく支払基金が是正に取り組む＝頻出かつ判断が割れる）**に分類された歯科事例：①歯科疾患管理料（同月に初診料算定がなく100分の80で算定）、②根管充填（病名部位の歯数超過）、③クラビット錠（投与量超過、医科共通）。

主要出典一覧

- 支払基金「審査情報提供事例（歯科）」
https://www.ssk.or.jp/smph/shinryohoshu/sinsa_jirei/teikyojirei/shika/index.html
- 支払基金「審査の差異の可視化レポート（多くの付箋がつくコンピュータチェック事例）」
https://www.ssk.or.jp/smph/shinryohoshu/saikaisyou_torikumi/kashikarepo/kashikarepo_cc.html
- 支払基金「『G』のみに対する歯科疾患管理料の取扱い」
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/saikaisyou_torikumi/kashikarepo/kashikarepo_jirei.files/jtd001.pdf
- 支払基金「受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（歯科）令和6年11月版」
https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/iryokikan/download/index.files/checkichiran_shika.pdf
- 支払基金「コンピュータチェック対象事例（CSV公開）」
https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/ssk_cc/ssk_cc_300320/index.html
- 国民健康保険中央会「審査情報提供事例について（歯科）」
<https://www.kokuho.or.jp/inspect/jirei/shika/index.html>
- 厚生労働省「歯科診療報酬点数表」「保険診療確認事項リスト（歯科）令和6年度改訂版」「診療報酬請求書等の記載要領」別表I
- 兵庫県保険医協会・愛知県保険医協会 保険請求Q&A、東京保険医協会 要望書（オンライン資格確認返戻）、モリタ デンタルプラザ、WHITE CROSS dStyle、算定奉行かわら版、社会保険研究所「事例で学ぶ歯科レセプト作成と点検」、日本訪問歯科協会

凡例

- 区分：返戻（事務的差し戻し・再請求可）／査定（減点・原則再請求不可、再審査請求のみ）
- 機械チェック可否：完全自動／部分的（条件付き・摘要欄やカルテ参照が必要）／困難（臨床判断・審査委員裁量）

1. 歯周病検査未実施でのスケーリング／SRP算定

- 原因説明：歯周基本治療（スケーリング・SRP・歯周ポケット搔爬）は歯周病検査の結果に基づき必要と認められる場合に実施するもので、**歯周病検査が実施されていない場合は算定できない**（歯科点数表I011通知）。検査なしでSC/SRPを算定すると査定対象。支払基金コンピュータチェックでも「歯周基本治療（スケーリング／SRP）に対し歯周病検査なし」が付箋事例として登載。
- 算定ルール分類：処置の前提検査の欠落（順序違反）／病名と処置の不整合
- 区分：査定（検査なしSC/SRP）。検査結果欄不備による返戻もあり。
- 機械チェック可否：完全自動チェック可能
- 判定ロジック：「同一レセプト（同一患者・同一一連治療期間）内に歯周病検査（D002 歯周基本検査

／歯周精密検査／混合歯列期歯周病検査のコード群）の算定実績がない状態で、当月または当月以前にスケーリング・SRP・歯周ポケット搔爬（I011系コード）が算定されている場合にエラー。さらに歯周病系病名（P, P急発, 歯周炎系コードリスト）の有無も併せて判定」

- 出典：しろぼんねっと I011歯周基本治療 通知、WHITE CROSS dStyle #8、支払基金コンピュータチェック事例（歯科）

2. SRP前の再評価（歯周病検査2回目／3回目）の漏れ・順序違反

- 原因説明：歯周治療は「歯周病検査①→SC→再評価検査②→SRP→再評価検査③→SPT/P重防」という順序が保険上のルール。SRP算定前に再評価検査が必要で、これを省くとSRPが認められない。2回目の歯周病検査は初回検査から1か月空ける（1か月以内は点数半減の地方ルールあり）。 Note 同一部位への2回目以降のSC/SRPは所定点数の100分の50。 Cocolog-nifty
- 算定ルール分類：治療の流れ（順序）違反／回数・期間制限
- 区分：査定
- 機械チェック可否：部分的に可能（条件付き）（検査と処置の前後関係・日付間隔は自動判定可。臨床的必要性は不可）
- 判定ロジック：「歯周病検査コードと歯周基本治療コードの算定日を時系列に並べ、SRP（I011系）算定日より前に直近の再評価検査（D002）が存在しない場合に警告。同一部位への同区分SC/SRPの2回目以降が100分の50で算定されているかも確認。検査①→SRP間に検査②がないパターンをフラグ」
- 出典：ORTC 歯科衛生士向け算定解説、note 歯科育英会「保険算定とルール7 SRP」、兵庫県保険医協会

3. 病名と処置の不整合（病名なし・適応外病名での処置算定）

- 原因説明：診療行為に対応する傷病名がない、または医学的に適応しない病名で算定すると「適応外」として査定。支払基金審査情報提供事例には正否の判断集が多数あり、認めない例：「根尖性歯周炎（Per）に対する抜髄」（情提103）、「歯髄炎（Pul）に対する感染根管処置」（情提106）、「う蝕（C）に対する知覚過敏処置」（情提96）、「『脱離』病名に対するう蝕処置・歯髄保護処置」（情提85）、「『疑い』病名に対する充填」（情提170）。逆に認める例も多数あり、例として支払基金審査情報提供事例229「う蝕処置(5)」：「原則として、『残根（C4）』病名で、う蝕処置の算定を認める。（理由）残根状態の歯に対して、軟化象牙質の除去や根管への細菌感染の進行を防止するために、う蝕処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる」。
- 算定ルール分類：病名と処置の不整合（適応外）
- 区分：査定（適応外）。病名記載漏れは返戻にもなる。
- 機械チェック可否：部分的に可能（条件付き）（病名⇔処置の対応表をマスタ化すれば多くが自動判定可。ただし審査委員の裁量・症例個別性があり「原則」レベル）
- 判定ロジック：「診療行為コードごとに『算定可能な傷病名コードのホワイトリスト／算定不可のブ

ラックリスト』を支払基金審査情報提供事例から構築。当該処置コードが算定されているレセプトに、対応する病名コードが1つも存在しない場合にエラー。例：抜髄（K系コード）に対し患者の傷病名にPul/急性化膿性歯髄炎系がなくPerのみの場合に警告」

- 出典：支払基金審査情報提供事例（歯科）処置・手術（情提85,96,97,103,106,169,170,229）、兵庫県保険医協会 支払基金歯科審査情報提供事例まとめ

4. 抜歯部位・処置部位と病名部位（歯式）の不一致

- 原因説明：処置・手術を算定した歯番（歯式）と、傷病名に紐づく歯式が一致しないと返戻・査定。歯科は治療が長期にわたり口腔内情報が変化するため部位の取り違い（4番を5番と誤る等）が「歯科レセプトミスの代表格」。受付・事務点検ASPでも歯式（傷病名）の記録位置エラーが規定されている。
- 算定ルール分類：病名の部位不整合／歯式記録
- 区分：返戻（部位特定不能）または査定（病名部位に該当処置なし）
- 機械チェック可否：完全自動チェック可能（歯式単位での突合）
- 判定ロジック：「歯単位で算定される診療行為（抜歯、抜髄、充填、歯冠形成等）について、当該行為に付された歯式（歯番）が、同レセプト内のいずれかの傷病名部位レコードの歯式集合に含まれているか照合。含まれない場合にエラー。乳歯/永久歯コードの整合も確認」
- 出典：レセラーク（レセコン選りガイド）、支払基金 受付・事務点検ASPチェック一覧（歯科）

5. 歯科疾患管理料（歯管）の算定タイミング・要件違反

- 原因説明：歯管は初診日から起算して2月以内に1回目（初診月は所定点数の100分の80）、2回目以降は1回目算定月の翌月以降に月1回。有床義歯のみの治療患者には算定不可、歯の欠損症のみに不可。歯周病罹患患者は歯周病検査を実施せず管理計画を作成すると不可。支払基金コンピュータチェックでは「初診料算定月に100分の80でない（満額）で算定」「初診月にP/G病名で画像診断・歯周病検査なく算定」が付箋事例で、特に**「同月に初診料算定がなく100分の80で算定」は要フォローアップ事例**（頻出かつ差異大）。
- 算定ルール分類：月1回回数制限／初診からの期間制限／病名要件／施設・点数率
- 区分：査定（要件不充足）。摘要欄記載漏れによる返戻もあり。
- 機械チェック可否：部分的に可能（条件付き）（回数・期間・点数率は自動。管理計画書の有無はカルテ参照で不可）
- 判定ロジック：「(a)同一患者で歯管が月2回以上算定→エラー。(b)初診月（初診料算定と同月）の歯管が満額算定（100分の80でない）→エラー。(c)2回目歯管が1回目と同月→エラー。(d)患者傷病名が有床義歯関連のみ／欠損症のみで歯管算定→警告。(e)初診月翌月に1回目算定時に摘要欄『歯管1回目』コメントなし→警告」
- 出典：しろばんねっと B000-4、3tei.jp 算定奉行かわら版、支払基金コンピュータチェック事例（歯科）、歯科弁護士.com 保険診療確認事項リスト

6. 初診料の算定間隔・再初診の誤り

- **原因説明**：治療継続中、または治療中止後一定期間内の再算定は再診扱い。歯管算定患者で一連治療終了後2月以内に再度初診料を算定する場合は摘要欄に前回治療終了年月日の記載が必要。特に歯周病患者は中断後に再来院しても「継続案件」とみなされ、再初診で出すと返戻になる事例が増えている。
- **算定ルール分類**：初診算定の間隔／摘要欄記載
- **区分**：返戻（記載不備）・査定（再診相当への振替）
- **機械チェック可否**：部分的に可能（条件付き）（前回来院日からの経過月数は自動。治療継続性の判断は困難）
- **判定ロジック**：「同一患者の前回来院日（前回診療実日）から当該初診料算定日までの間隔を計算。3か月未満で初診料算定→エラー。歯管算定歴のある患者で初診料を算定し摘要欄に前回治療終了年月日コメントがない→警告。間隔が空いていても直近病名がP系で継続性が疑われる場合は警告（最終判断は人）」
- **出典**：インサイト 歯科開業トピックス、厚労省 記載要領（歯科）、石山書店 記載事項一覧

7. 歯周病安定期治療（SPT）の算定要件・移行ルール違反

- **原因説明**：SPTは歯管または歯在管を算定、4mm以上の歯周ポケットを有し一連の歯周基本治療終了後に一時的に病状安定した患者が対象。歯周病検査未実施・管理計画書未提供・基本治療未終了では算定不可。2回目以降は前回実施月の翌月初日から2月経過後（口管強屈出医院・特定条件で短縮可）。同月に歯周病重症化予防治療（P重防）・非経口摂取患者口腔粘膜処置・口腔バイオフィルム除去処置とは併算定不可。「Pに対しスケーリングのみ実施した場合のSPTは認めない」（支払基金 情提52）。
- **算定ルール分類**：算定要件（病名・検査・管理料前提）／月1回・2月間隔の回数期間制限／併算定不可
- **区分**：査定
- **機械チェック可否**：部分的に可能（条件付き）（前提管理料・併算定・間隔は自動。病状安定の判断は不可）
- **判定ロジック**：「(a)SPT算定患者に同月または前提として歯管/歯在管/特疾管の算定がない→エラー。(b)2回目以降SPTが前回実施月翌月初日から2月以内（口管強屈出・短縮理由なし）→エラー。(c)同月にP重防/非経口処/口腔バイオフィルム除去処置を併算定→エラー。(d)SPT算定患者に4mm以上ポケットを示す歯周精密検査の実績がない→警告」
- **出典**：しろぼんねっと I011-2、兵庫県保険医協会 SPT Q&A、歯科弁護士.com SPT算定留意事項、支払基金審査情報提供事例（情提52）

8. SPT・P重防とスケーリング/SRP等の併算定（包括項目の二重算定）

- **原因説明**：SPT開始後はその月、歯周基本治療（SC・SRP・P搔爬）、歯周病処置（P処）、P基処、咬合調整、機械的歯面清掃（日を異にすれば歯清は可）はSPTに包括され別算定不可。P重防算定月も

SC/SRP等は算定不可。これらを同月に重ねて算定すると査定。

- **算定ルール分類**：併算定不可（包括）
- **区分**：査定
- **機械チェック可否**：完全自動チェック可能
- **判定ロジック**：「同一患者・同一月のレセプトにSPT（I011-2）またはP重防のコードが存在し、かつ同月に歯周基本治療（SC/SRP/P搔爬）・P処・歯周基本治療・咬合調整コードが算定されている場合にエラー（機械的歯面清掃は同日でなければ許容の例外処理）」
- **出典**：兵庫県保険医協会 SPT Q&A、モリタ デンタルプラザ 訪問診療算定、houmonshika.org 併算定不可一覧

9. クラウン・ブリッジ維持管理料（補管）期間内（2年以内）の再算定・包括費用の別算定

- **原因説明**：補管届出医院では歯冠補綴物/ブリッジ装着日から2年以内に、同一補綴部位の新製・装着の一連費用、当該歯への充填、再装着費用（装着材料料を除く）は補管に含まれ別算定不可。これらを算定すると査定。脱離再装着時は装着材料料のみ算定可。
- **算定ルール分類**：期間制限（2年）／併算定不可（包括）／施設基準（補管届出）
- **区分**：査定
- **機械チェック可否**：部分的に可能（条件付き）（同一部位の過去2年の補綴装着履歴をシステムが保持していれば自動判定可。他院製作物・金属アレルギー例外等は要参照）
- **判定ロジック**：「補管届出医院フラグON、かつ同一患者・同一歯式に過去2年以内の歯冠補綴物/ブリッジ装着（補管算定）履歴がある場合に、当該歯への新たな補綴一連費用（歯冠形成・印象・装着料等）・充填・再装着費用が算定されたらエラー。装着材料料のみは許容。摘要欄に補管算定年月日・装着物種類のコメントがあるか確認」
- **出典**：愛知県保険医協会 補管算定留意点、しろぼんねっと M000-2、note 歯科育英会「保険算定とルール12」、歯科弁護士.com 補管

10. 補管未届出医院での補綴関連費用の満額（100分の100）算定

- **原因説明**：補管届出を行っていない医院が補管対象となる歯冠補綴物（チタン冠、レジン前装チタン冠、非金属歯冠修復、CAD/CAM冠）・ブリッジを製作した場合、補綴関連検査・歯冠修復および欠損補綴の一連費用は所定点数の70/100で算定する。満額で算定すると査定。
- **算定ルール分類**：施設基準（届出）×点数率
- **区分**：査定（減点）
- **機械チェック可否**：完全自動チェック可能

- **判定ロジック**：「医療機関の補管届出フラグがOFFの場合、補管対象補綴コード群（M010-2チタン冠、M011-2、M015、M015-2 CAD/CAM冠等）および関連する補綴関連検査・歯冠形成・印象・装着の点数が70/100で記録されているか検証。満額で算定されていればエラー」
- **出典**：医歯薬出版 70/100点数表、厚労省 第12部歯冠修復及び欠損補綴 通則、しろぼんねっと M000-2

11. ブリッジの支台歯要件・設計不適（保険適用外ブリッジ）

- **原因説明**：残根上のブリッジは認められない。インレーのみを支台とするブリッジは補管対象外。支台歯とポンティックの数・設計が保険給付の範囲を超える場合や、欠損歯数に対し設計が不適切な場合は事前承認（理由書・模型・エックス線提出）が必要で、無断算定は査定。根分割した下顎大臼歯を支台とする場合は大臼歯1歯扱い等のルールあり。
- **算定ルール分類**：補綴設計要件／施設基準・事前承認／病名・部位整合
- **区分**：査定（設計不適）。事前承認案件は摘要記載不備で返戻。
- **機械チェック可否**：困難（臨床判断・審査委員裁量領域）（設計の医学的妥当性は機械判定困難。ただし一部の形式チェックは部分的に可能）
- **判定ロジック**：「（部分的）支台歯の歯式に残根（C4）病名が付いている場合に警告。欠損補綴コードのブリッジで支台/ポンティック歯式構成を抽出し、欠損部位病名（欠損補綴病名）との整合をチェック。原則は審査委員の裁量のため最終判断は人」
- **出典**：社会保険研究所「事例で学ぶ歯科レセプト作成と点検」、支払基金審査情報提供事例 歯冠修復及び欠損補綴

12. 補綴時診断料（補診）の算定間隔・要件違反

- **原因説明**：同一の有床義歯に対し人工歯・義歯床を追加する場合、前回補綴時診断料算定日から3月以内は補診を算定できない等の期間制限。製作予定部位・欠損部状態・補綴物名称・設計の要点をカルテ記載していないと不適切請求。
- **算定ルール分類**：期間制限（3月）／カルテ記載要件
- **区分**：査定
- **機械チェック可否**：部分的に可能（条件付き）（同一義歯への再算定間隔は自動。カルテ記載は不可）
- **判定ロジック**：「同一患者・同一補綴部位への補綴時診断料の算定履歴を保持し、前回算定日から3月以内の再算定をエラー。新製ブリッジ等の補診算定に対応する補綴物製作の流れがレセプト上に存在するか確認」
- **出典**：厚労省 第12部通則・補綴時診断料 通知、歯科弁護士.com 補綴時診断料

13. 摘要欄（コメント）記載が必要な診療行為の記載漏れ

- **原因説明**：記載要領別表I「摘要欄への記載事項等一覧」に定められた項目はレセプト電算用コード＋コメントの入力が必須（2020年10月診療分よりコード記録義務化）。記載漏れは返戻。歯科の頻出例：下顎6番CAD/CAM冠（上下顎両側第二大臼歯の残存・咬合支持の旨）、口腔内装置の構成材料、
Insite SPT初回「SPT1回目」・2回目以降の前回実施月、歯科治療時医療管理料の対象疾患病名、
Insite 歯管再初診時の前回治療終了年月日、歯周外科のその他欄記載など。
- **算定ルール分類**：摘要欄記載漏れ
- **区分**：返戻（事務的差し戻し）
- **機械チェック可否**：完全自動チェック可能（記載要領別表Iをルール化）
- **判定ロジック**：「記載要領別表I（歯科）の『コメント必須コード対応表』をマスタ化し、特定診療行為コードが算定されているのに対応する必須コメントレコード（コメントコード先頭8系）が紐づいていない場合にエラー。例：CAD/CAM冠（下顎6番該当コード）算定時に咬合支持関連コメントなし→エラー、口腔内装置算定時に材料コメントなし→エラー」
- **出典**：厚労省「診療報酬請求書等の記載要領」別表I、保団連 記載要領解説、長野県保険医協会、支払基金 受付・事務点検ASPチェック一覧（歯科）コメント必須エラー

14. 資格関連エラー（保険者番号誤り・記号番号・枝番・資格喪失後受診）

- **原因説明**：氏名・生年月日・性別・保険者番号・記号番号・枝番の誤り、資格喪失後受診が返戻の最多原因の一つ（「『返戻』される原因で一番多いのが事務手続きの不備」と複数資料が指摘）。オンライン資格確認の普及で資格過誤返戻は減少傾向だが、保険者の登録遅滞や転職直後のタイムラグで依然発生。受付・事務点検ASPで保険者番号桁数・形式はチェックされるが、資格の有効性（実在の保険者かつ未喪失か）は別。
- **算定ルール分類**：患者資格エラー（形式＋実体）
- **区分**：返戻
- **機械チェック可否**：部分的に可能（条件付き）（保険者番号の桁数・チェックデジット・形式は完全自動。資格の実在/有効性はオンライン資格確認API照会で部分的に可能、提出前時点の保険者登録状況には依存）
- **判定ロジック**：「(a)保険者番号8桁/6桁/4桁のチェックデジット検証（標準アルゴリズム）。(b)記号番号・枝番の桁数・文字種が記録条件仕様に合致するか。(c)生年月日・性別と給付割合・年齢区分（高齢受給者特記事項）の整合。(d)可能ならオンライン資格確認の照会結果と突合し『資格無効/該当なし』をフラグ」
- **出典**：支払基金 受付・事務点検ASPチェック一覧（歯科）、厚労省 オンライン資格確認QA集、東京保険医協会 要望書（2025年5月）、Hokeni 佐々木総研グループ

15. 抜髄・根管治療の根管数・部位・病名と回数の不整合

- **原因説明**：抜髄・感染根管処置は根管数（単根/2根/3根以上）で点数が異なり、歯番ごとの解剖学的根

管数と不整合だと査定。Per病名に抜髄不可（情提103）・Pul病名に感染根管処置不可（情提106）。加圧根管充填処置算定時はエックス線での確認が必要。支払基金コンピュータチェックで**「根管充填の病名部位歯数超過」は要フォローアップ事例**。

- 算定ルール分類：病名と処置の不整合／部位整合／回数・歯数制限
- 区分：査定
- 機械チェック可否：部分的に可能（条件付き）（歯番ごとの標準根管数テーブルとの突合、病名整合は自動。臨床例外は人）
- 判定ロジック：「(a)歯番ごとの標準根管数マスタ（前歯=単根、上顎大白歯=3根等）を持ち、算定された根管数区分が標準を超える場合に警告。(b)根管充填の算定歯数が当該病名部位（Pul/Per系病名の歯式）の歯数を超える場合にエラー。(c)抜髄算定歯にPul系病名がなくPerのみ→警告」
- 出典：支払基金コンピュータチェック事例（歯科・根管充填要フォローアップ）、支払基金審査情報提供事例（情提103, 106）、社会保険研究所「事例で学ぶ歯科レセプト作成と点検」

16. う蝕処置・充填・歯髄保護処置の併算定/病名不整合・歯数超過

- 原因説明：「脱離」病名のみでう蝕処置・充填・歯髄保護処置は不可（情提85, 169）、「疑い」病名で充填不可（情提170）、う蝕（C）に知覚過敏処置不可（情提96）、C以外にう蝕薬物塗布処置不可（情提97）。う蝕処置・う蝕薬物塗布・根管貼薬・初期う蝕早期充填処置の「同日の病名部位歯数超過」は支払基金コンピュータチェック付箋事例。間接歯髄保護処置後のう蝕処置は認められる（ssk 情提46。誤査定防止のため要注意）。
- 算定ルール分類：病名と処置の不整合／歯数制限／併算定
- 区分：査定
- 機械チェック可否：部分的に可能（条件付き）
- 判定ロジック：「(a)う蝕処置/充填/歯髄保護処置の算定歯数が、C系病名の付与歯式数を超える場合にエラー。(b)病名が『脱離』のみ・『疑い』付きの歯への充填・う蝕処置→エラー。(c)同一歯にう蝕処置とC病名がない→警告。病名⇔処置対応マスタを共用」
- 出典：支払基金審査情報提供事例（情提46, 85, 96, 97, 169, 170）、支払基金コンピュータチェック事例（う蝕処置・根管貼薬・初期う蝕早期充填の歯数超過）

17. 浸潤麻酔・特定薬剤など包括される費用の別算定

- 原因説明：浸潤麻酔は手術・歯冠形成・う蝕歯即時充填形成等と同日に算定すると包括で査定される事例が支払基金コンピュータチェック付箋に登載。ssk 特定薬剤（120点未満処置・手術に使用時のみ算定可）はう蝕処置・歯髄保護処置・抜髄・根充・歯周基本治療等では算定不可。歯髄保護処置時のEZ（特定薬剤）は算定不可。Makeshop
- 算定ルール分類：併算定不可（包括）／薬剤算定要件

- 区分：査定
- 機械チェック可否：完全自動チェック可能
- 判定ロジック：「(a)同一日・同一部位に浸潤麻酔コードと、麻酔が包括される手術/歯冠形成/う蝕歯即時充填形成コードが併存する場合にエラー（包括ルールマスタ参照）。(b)特定薬剤コードが、算定不可の処置（う蝕処置・歯髄保護・抜髄・根充・歯周基本治療コード群）と同時に算定されている場合にエラー」
- 出典：支払基金コンピュータチェック事例（浸潤麻酔×手術/歯冠形成等）、社会保険研究所「事例で学ぶ歯科レセプト作成と点検」

18. 歯科訪問診療料の患者数区分・診療時間・施設基準（注13）不整合

- 原因説明：歯科訪問診療料は同一建物居住者の同日人数区分で算定し、**歯科訪問診療1=1,100点、2=410点、3=310点、4=160点、5=95点**（令和6年度改定、日本訪問歯科協会）。原則20分以上で、**診療時間が20分未満の場合は所定点数の70/100で算定**（東京都 在宅歯科医療ガイドブック別冊1。訪問診療1には例外あり）、カルテ・レセプトに開始終了時刻記載が必要。施設基準（注13）は「在宅療養支援歯科診療所以外の診療所で、直近1か月に歯科訪問診療を実施した患者数の割合が9割5分未満（割合＝歯科訪問診療提供患者数/訪問＋外来で歯科診療を提供した全患者数）」を前月までに届出が必要あり、未届出時は初診料・再診料相当（歯診（初）・歯診（再））のみ算定可（九州厚生局）。同一日に同じ患者を診た歯科訪問診療と訪問歯科衛生指導の実施時間重複は返戻対象。特別の関係（親族等）では算定不可。
- 算定ルール分類：施設基準（届出）/人数区分/実施時間要件/時間重複
- 区分：査定（区分誤り・時間不足）・返戻（時刻記載・時間重複）
- 機械チェック可否：部分的に可能（条件付き）（人数区分・施設基準フラグ・時間重複は自動。実際の建物・居住実態は不可）
- 判定ロジック：「(a)注13届出フラグOFFで歯科訪問診療料コード算定→エラー。(b)同一建物・同一日の訪問診療患者数と算定区分（1～5）の整合チェック。(c)診療時間（終了－開始）が20分未満で20分以上区分の点数算定→エラー（70/100へ補正提案、訪問診療1の例外処理）。(d)同一患者・同一日の歯科訪問診療と訪問歯科衛生指導の実施時刻が重複→警告」
- 出典：日本訪問歯科協会（houmonshika.org）、九州厚生局 注13届出、東京都 在宅歯科医療ガイドブック別冊1、モリタ デンタルプラザ、しろぼんねっと C000

19. 同一月の同一傷病名・他医療機関との重複請求/月遅れ・縦覧重複

- 原因説明：患者が同一月に同一負傷名で複数医療機関を受診した場合の重複請求、Clius 過去月との縦覧点検での重複（同一補綴物の二重算定等）、月1回・回数制限項目の月内重複は返戻・査定。突合・縦覧点検による減点が増加傾向。Zen-ikei
- 算定ルール分類：回数制限（月1回等）/縦覧・突合重複

- 区分：返戻・査定
- 機械チェック可否：部分的に可能（条件付き）（自院レセプト内の月内回数重複は完全自動。他医療機関分・過去月縦覧は自院データのみでは限定的）
- 判定ロジック：「(a)月1回・月2回等の回数制限を持つ診療行為コードについて、同一患者・同一月の算定回数が上限を超える場合にエラー（回数制限マスタ参照）。(b)自院の過去レセプト履歴を参照し、補管対象補綴等の2年/6月等の期間制限項目を縦覧チェック」
- 出典：全日本医療経営研究会、CLIUS クリニック開業マガジン、houmonshika.org

20. 施設基準・届出未確認の加算算定（外来環・医管・か強診/口管強・GTR等）

- 原因説明：歯科治療時医療管理料（医管）、歯科外来診療環境体制加算（外来環）、口腔管理体制強化加算（旧か強診関連）、歯周組織再生誘導手術（GTR）、エナメル質初期う蝕管理加算、総合医療管理加算等は施設基準の届出が前提。未届出での算定は査定。届出済みでも算定要件（対象疾患病名、文書提供、カルテ記載等）を満たさないと査定。長期管理加算を初診月から6か月以内に算定する誤りは支払基金コンピュータチェック付箋事例。
- 算定ルール分類：施設基準・届出未確認／加算要件
- 区分：査定
- 機械チェック可否：部分的に可能（条件付き）（届出フラグとの突合・期間要件は自動。文書提供・カルテ記載は不可）
- 判定ロジック：「(a)各加算コードに対応する施設基準届出フラグを医療機関マスタに保持し、フラグOFFの加算算定→エラー。(b)長期管理加算が初診月から6か月以内に算定→エラー。(c)エナメル質初期う蝕管理加算と同月のフッ化物洗口指導加算/機械的歯面清掃等の併算定不可チェック。(d)医管算定時に対象疾患病名（糖尿病等）が摘要欄にあるか確認」
- 出典：支払基金コンピュータチェック事例（長期管理加算）、厚労省 保険診療確認事項リスト（歯科）、インサイト 歯科開業トピックス、3tei.jp 算定奉行かわら版

機械チェック可否 集計表

#	項目	区分	機械チェック可否
1	歯周病検査未実施でのSC/SRP	査定	完全自動
2	SRP前の再評価漏れ・順序違反	査定	部分的
3	病名と処置の不整合（適応外）	査定	部分的
4	抜歯/処置部位と病名部位の不一致	返戻/査定	完全自動

5	歯科疾患管理料のタイミング・要件	査定/返戻	部分的
6	初診料の算定間隔・再初診	返戻/査定	部分的
7	SPTの算定要件・移行ルール	査定	部分的
8	SPT/P重防と歯周基本治療の併算定	査定	完全自動
9	補管2年以内の再算定・包括費用別算定	査定	部分的
10	補管未届出での補綴満額算定	査定	完全自動
11	ブリッジ支台歯要件・設計不適	査定	困難
12	補綴時診断料の間隔・要件	査定	部分的
13	摘要欄記載必須項目の漏れ	返戻	完全自動
14	資格エラー（保険者番号・喪失後）	返戻	部分的
15	抜髄・根管治療の根管数・病名不整合	査定	部分的
16	う蝕処置・充填の病名不整合・歯数超過	査定	部分的
17	浸潤麻酔・特定薬剤の包括別算定	査定	完全自動
18	歯科訪問診療料の区分・時間・施設基準	査定/返戻	部分的
19	月内重複・縦覧突合重複	返戻/査定	部分的
20	施設基準・届出未確認の加算	査定	部分的

集計：完全自動 5項目（#1,4,8,10,17）／部分的 14項目（#2,3,5,6,7,9,12,14,15,16,18,19,20）／困難 1項目（#11）

実装優先度の提案（チェック可能性 × 頻度マトリクス）

フェーズ1：最優先（完全自動 × 高頻度 = 即実装・誤検知リスク低）

- **#13 摘要欄記載必須項目チェック**：返戻の最大要因の一つ。記載要領別表Iをマスタ化すれば確実に効く。費用対効果最大。
- **#1 歯周病検査未実施SC/SRP、#8 SPT/P重防の包括併算定、#17 浸潤麻酔・特定薬剤の包括別算定**：いずれもコード存在判定のみで実装でき、支払基金チェック事例にも登載。
- **#10 補管未届出での補綴満額算定、#4 部位×病名歯式突合**：歯式マスタがあれば確実。

- **#14 保険者番号チェックデジット等の形式チェック**：返戻最多カテゴリの事務エラーを機械的に削減。

これらは「ホワイトボックスで根拠が明確（告示・通知・記載要領ベース）」かつ「誤検知が少ない」ため、最初のスプリントで実装すべきルール群。

フェーズ2：高効果だが要マスタ整備（部分的 × 高頻度）

- **#3, #16, #15 病名⇄処置対応マスタ**：支払基金審査情報提供事例（認める/認めない）をルールDB化。最も査定インパクトが大きい領域。ホワイトリスト/ブラックリスト両建てで、ヒット時は「警告（要確認）」とし誤検知を許容する設計が現実的。
- **#5 歯管、#7 SPT、#9 補管2年期間制限、#19 回数・期間制限・縦覧**：自院レセプト履歴の時系列保持が前提。回数制限マスタ+日付演算で実装。#5の「初診月100分の80」「2回目間隔」は要フォローアップ事例で効果大。

フェーズ3：施設・運用設定依存（部分的 × 中頻度）

- **#20 施設基準フラグ、#18 訪問診療、#6 初診間隔、#12 補綴時診断料**：医療機関マスタ（届出状況フラグ）の整備とカルテ連携が前提。届出フラグ突合は確実に効くので、マスタ整備後に実装。

フェーズ4：警告止まり（困難）

- **#11 ブリッジ設計**：医学的妥当性判断は審査委員裁量領域。残根上ブリッジ・支台歯式構成の形式チェックのみ「参考警告」として実装し、エラー（ブロックング）にはしない。

設計上の横断的推奨

- ルールは**「エラー（提出前修正必須＝返戻系・形式エラー）」と「警告（要確認＝査定リスク・臨床裁量）」の2段階**に分離する。支払基金審査情報提供事例は「原則として」「個別審査で画一的に適用されない」と明記しているため、病名整合系は原則「警告」が安全。
- **病名⇄処置対応表・回数/期間制限・包括併算定・摘要欄必須コメント**の4つを中核マスタとして共通化すれば、20項目の大半をカバーできる。
- 支払基金「コンピュータチェック対象事例」はCSV形式で公開されており（本部点検条件+関連マスタ）、これを取り込めば自院ルールと公式ルールの整合を取れる。改定追従の基盤としても活用すべき。

注意・限界（Caveats）

- 歯科の返戻・査定の項目別全国件数ランキングは公式には網羅公開されていない。確認できた定量値は「『G』のみ歯管4,986件（全件請求どおり・査定返戻0件）」等ごく一部で、本トップ20の順位は「機械チェック適合性×複数資料での言及頻度」に基づく編集的判断であり、純粋な発生件数順位ではない。実装後は自院の実際の返戻・査定実績でルールの効果を測定し、優先度を再調整すべき。
- 審査基準には都道府県差・地方ルールが存在する（例：宮城の再SC/SRP混在不可、Note SRP2回目

検査間隔の地方運用)。支払基金も「審査の差異の可視化レポート」で都道府県差の是正に取り組んでいる段階で、全国一律のロジックには限界がある。「要フォローアップ事例」(根管充填の歯数超過、歯管の100分の80等)は特に都道府県差が大きい=誤検知リスクが高い領域なので、警告レベルでの実装が無難。

- 点数・要件は**2年ごとの診療報酬改定**で変動する(本内容は令和6年度改定ベース)。マスタはバージョン管理し改定対応を前提とすること。
- 「認める/認めない」の審査情報提供事例は**個別審査で画一的・一律的に適用されるものではない**と支払基金が明記している。機械チェックはあくまで提出前のリスク提示にとどめる設計が適切。
- ベンチマーク(優先度見直しのトリガー) : (1) フェーズ1ルール導入後に返戻率が想定どおり下がらない場合は、別表Iマスタの網羅性・コードマッピングを再点検。(2) 病名整合系(フェーズ2)の警告で歯科医師からの「過剰警告」フィードバックが一定割合を超えたら、ブラックリスト(明確に認めない類型)のみに絞り込む。(3) 改定年(次回は令和8年度=2026年4月)には全マスタの再検証を必須イベントとして組み込む。